PROTOCOLO ERAS

DR. ALFREDO MATOS

¿Qué es el Protocolo ERAS / ACERTO?
Es un programa multimodal de cuidados perioperatorios diseñado para acelerar la recuperación del paciente quirúrgico, reducir complicaciones y optimizar recursos hospitalarios.

- **ERAS:** Enhanced Recovery After Surgery (Sociedad Internacional).
- **ACERTO:** Acelerando la Recuperación Total Posoperatoria (Adaptación latinoamericana/Brasil).

Manejo Tradicional vs. Protocolo ERAS/ACERTO

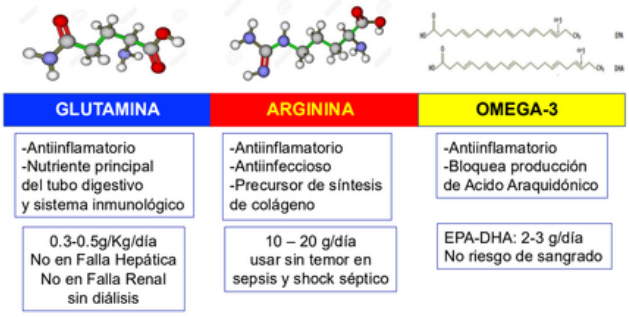
Parámetro	Manejo Tradicional	Protocolo ERAS / ACERTO
Evaluación previa	Sin nutrición perioperatoria estándar	Terapia / Inmunonutrición (7–14 días previas)
Preparación de colon	De rutina	Restringida / No de rutina
Ayuno preoperatorio	8 a 12 horas ("Nada por boca" desde medianoche)	Abreviado: 6h sólidos / 2h líquidos claros (con
Sonda nasogástrica / Drenes	De rutina	Uso selectivo / Restringido
Realimentación postop.	Retardada (2.° a 4.° día)	Precoz (Inmediata o 1.er día posoperatorio)
Fluidoterapia I.V.	Continuada por 4 a 7 días	Restringida / Solo el 1.er día o según metas

POR QUÉ IMPLEMENTAR ERAS

- Estancia hospitalaria: reducción del 35–40%.
- Menos complicaciones quirúrgicas (fugas anastomóticas) y no quirúrgicas (infecciones nosocomiales).
- Infecciones: 42% menos infecciones generales.
- Retorno más temprano al trabajo y mejor calidad de vida.
- Costos: reducción del 28–32%, tanto en países desarrollados como en desarrollo.

COMPONENTE NUTRICIONAL DE ERAS

- Carga de carbohidratos, inmunonutrición (glutamina, arginina, omega-3) y prehabilitación nutricional con proteínas 1,5–2 g/kg/día; se desarrollan en el tema Nutrición en cirugía.



SITUACIONES QUE RETRASAN LA RECUPERACIÓN

- Dolor, náuseas y vómitos.
- Inmovilidad prolongada.
- Sonda nasogástrica, sonda urinaria y drenajes de rutina.
- Líquidos intravenosos prolongados.
- «Nada por boca» posoperatorio para «proteger la anastomosis» o por íleo: sin beneficio demostrado.

ORIGEN DEL PROTOCOLO

- Propuesto por Henrik Kehlet; adoptado inicialmente en cirugía colorrectal y hoy aplicable a toda cirugía mayor.
- Referentes: ERAS Society, ACERTO (Brasil/Latinoamérica), ASER y EBPOM.

VENTAJAS

- Acorta la estancia hospitalaria.
- Reduce los costos totales.
- Reduce complicaciones posoperatorias y reingresos.
- Mejora la experiencia del paciente.

PROTOCOLO ERAS

DR. ALFREDO MATOS

RIESGO QUIRÚRGICO: CONTEXTO MUNDIAL

- Mortalidad posoperatoria global baja (1–4%).
- El 13% de los procedimientos son de alto riesgo (>5% de mortalidad) y concentran el 80% de las muertes posoperatorias.
- El riesgo de morir en los 30 días posoperatorios es ~1 000 veces mayor que durante la cirugía misma.
- Complicaciones más letales: ACV, IAM, SDRA, falla renal aguda y lesión intestinal aguda.
- El adulto mayor requiere cirugía hasta 4 veces más que el resto de la población.

ENVEJECIMIENTO

- Población mundial y pacientes quirúrgicos cada vez más viejos.
- Cambios: menor capacidad de ejercicio, fragilidad, malnutrición y comorbilidades crónicas.

HOMEOSTENOSIS

- Reserva fisiológica reducida con menor resistencia al estrés.
- Un estrés quirúrgico que tolera el joven puede superar el límite fisiológico del anciano y causar daño orgánico.

PREHABILITACIÓN

- Trimodal (nutricional, física y psicológica): «1 + 1 + 1 = 4».
- El Hospital Clínic de Barcelona redujo 50% las complicaciones en pacientes de alto riesgo con prehabilitación.

CPET

- Prueba de esfuerzo cardiopulmonar: estándar de oro para medir la capacidad de ejercicio y definir el riesgo quirúrgico.
- Umbral anaeróbico <11 mL/min/kg = alto riesgo de muerte.
- Un entrenamiento eficaz debe elevar el umbral anaeróbico y el VO_2 máximo.

ELEMENTOS DEL PROTOCOLO POR FASE

- Preoperatorio: identificar al paciente, educación, cribado de malnutrición, bebida de carbohidratos, preparación de colon selectiva y cese del tabaco.
- Intraoperatorio: cirugía mínimamente invasiva, fluidoterapia guiada por objetivos, anestesia regional, profilaxis de NVPO, antibiótico antes de la incisión y tromboprofilaxis.
- Posoperatorio: alimentación y movilización tempranas, líquidos optimizados, analgesia multimodal y sin SNG ni sonda urinaria de rutina.

AYUNO PREOPERATORIO: REGLAS PRÁCTICAS

- Sólidos: 6 h (más si son comidas grasas o fritas).
- Leche materna: 4 h.
- Líquidos claros (agua, té sin leche, café negro, jugos claros): hasta 2 h.
- Bebida de carbohidratos: 800 mL la noche previa + 400 mL en la mañana, con preparado comercial de osmolaridad adecuada; omitir en diabéticos.
- ASA, Royal College, Cochrane y las sociedades europea, canadiense y australiana aceptan 2 h para líquidos y 6 h para sólidos.
- Los líquidos claros hasta 2 h antes no aumentan el residuo gástrico.

EL PROBLEMA DEL «NADA POR BOCA»

- Es la orden más escrita en los hospitales: >50% de los pacientes en NPO no lo necesitan y >50% de los que sí, no reciben nutrición parenteral.
- NPO desde la noche previa produce disconfort, cefalea, sed, ansiedad, hambre y balance nitrogenado negativo.

